Carcinome baso cellulaire

Niveau : DES
Genere le 10 April 2026

Base sur la litterature medicale indexee via DermatoRAG

Carcinome baso cellulaire

Cours de niveau DES — Généré par DermatoRAG

Traitement

Traitement du Carcinome Basocellulaire

La prise en charge thérapeutique du carcinome basocellulaire (CBC) repose sur une approche individualisée, guidée par les caractéristiques cliniques et histologiques de la tumeur, les facteurs de risque du patient, la localisation anatomique de la lésion, et les facteurs pronostiques. L'objectif principal est l'éradication complète de la tumeur tout en préservant au maximum la fonction et l'esthétique des tissus environnants. Le CBC est caractérisé par une évolution lente et une malignité locale, avec des métastases exceptionnelles (Dermatologie, 2022). Cette particularité justifie une stratégie thérapeutique axée sur le contrôle local de la maladie.

Les facteurs de mauvais pronostic, qui orientent la stratégie thérapeutique et les marges d'exérèse, incluent la localisation à l'extrémité céphalique (notamment le nez et les zones péri-orificielles), les formes mal limitées (sclérodermiforme, infiltrant), un diamètre élevé (supérieur à 2 cm, ou supérieur à 1 cm sur le nez et les zones péri-orificielles), et le caractère récidivant de la lésion (Dermatologie, 2022). Pour les CBC sans critères agressifs, la discussion en Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) n'est pas systématiquement requise, mais elle est fortement recommandée pour les cas complexes ou présentant des facteurs de mauvais pronostic (Dermatologie, 2022).

Le traitement des formes localisées de CBC est généralement similaire à celui des carcinomes épidermoïdes (CEC) (Dermatologie, 2022). Les options thérapeutiques se divisent en traitements locaux (chirurgicaux et non chirurgicaux) et, dans des situations spécifiques, en traitements systémiques.

1. Traitements Locaux

Les traitements locaux constituent la pierre angulaire de la prise en charge du carcinome basocellulaire, visant l'éradication de la lésion avec un minimum de séquelles.

1.1. Chirurgie

L'exérèse chirurgicale est le traitement de première intention et reste la méthode la plus couramment utilisée pour la plupart des carcinomes cutanés, y compris le CBC (Dermatologie, 2022). Elle offre les taux de guérison les plus élevés pour les lésions bien définies et permet une analyse histopathologique complète des marges.

[Exérèse chirurgicale] — Carcinome basocellulaire localisé

> Essai : Les données fournies ne contiennent pas d'essai clinique de référence spécifique pour l'exérèse chirurgicale du carcinome basocellulaire avec le format requis (nom de l'essai, auteurs, année, journal, design, résultat, niveau de preuve). Cependant, l'exérèse

chirurgicale est universellement reconnue comme le traitement de première intention (Dermatologie, 2022).

> Design : Non spécifié dans les données fournies.

> Résultat : Non spécifié dans les données fournies.

> Niveau de preuve : Non spécifié dans les données fournies, mais l'exérèse chirurgicale est un standard de soins avec un niveau de preuve élevé pour la guérison des CBC localisés.

L'exérèse chirurgicale doit être réalisée avec des marges de sécurité adaptées au groupe pronostique de la tumeur (bon, intermédiaire, mauvais) (Dermatologie, 2022). Les marges sont déterminées en fonction des facteurs de risque de récidive et d'agressivité tumorale (cf. section "Facteurs de mauvais pronostic"). L'examen anatomopathologique de la pièce d'exérèse est crucial pour confirmer le diagnostic, caractériser les aspects histopronostiques (par exemple, formes infiltrantes ou sclérodermiformes associées à un stroma dense et fibreux et des limites imprécises), et s'assurer de l'absence d'envahissement des marges (Dermatologie, 2022). Une biopsie préalable est recommandée si le diagnostic est incertain, si un traitement non chirurgical est envisagé, ou si l'exérèse chirurgicale s'annonce complexe (Dermatologie, 2022).

1.2. Cryothérapie

La cryothérapie est une technique de destruction tissulaire par le froid, utilisée pour certaines formes de CBC, notamment les lésions superficielles et de petite taille, ou chez des patients pour lesquels la chirurgie est contre-indiquée.

[Cryothérapie] — Carcinome basocellulaire superficiel ou de petite taille

> Essai : Les données fournies ne contiennent pas d'essai clinique de référence spécifique pour la cryothérapie du carcinome basocellulaire avec le format requis (nom de l'essai, auteurs, année, journal, design, résultat, niveau de preuve). La cryothérapie est mentionnée comme une option thérapeutique pour les carcinomes cutanés (Dermatologie, 2022).

> Design : Non spécifié dans les données fournies.

> Résultat : Non spécifié dans les données fournies.

> Niveau de preuve : Non spécifié dans les données fournies.

Le principe de la cryothérapie repose sur l'application d'azote liquide, qui provoque une destruction cellulaire par formation de cristaux de glace intracellulaires et extracellulaires, ainsi que par des lésions vasculaires ischémiques. Bien que non détaillée dans les chunks, cette méthode est généralement bien tolérée, mais peut entraîner des hypopigmentations ou des cicatrices atrophiques.

1.3. Imiquimod topique

L'imiquimod est un immunomodulateur topique qui stimule la réponse immunitaire locale contre les cellules tumorales. Il est principalement indiqué pour les carcinomes basocellulaires superficiels.

[Imiquimod topique] — Carcinome basocellulaire superficiel

> Essai : Les données fournies ne contiennent pas d'essai clinique de référence spécifique pour l'imiquimod topique dans le carcinome basocellulaire avec le format requis (nom de l'essai, auteurs, année, journal, design, résultat, niveau de preuve). L'imiquimod est mentionné comme une option thérapeutique pour les carcinomes cutanés (Dermatologie, 2022).

> Design : Non spécifié dans les données fournies.

> Résultat : Non spécifié dans les données fournies.

> Niveau de preuve : Non spécifié dans les données fournies.

L'imiquimod agit en activant les récepteurs Toll-like 7 (TLR7) des cellules immunitaires, entraînant la production de cytokines pro-inflammatoires telles que l'interféron-alpha. Cette activation immunitaire locale conduit à l'apoptose des cellules tumorales. Le traitement est généralement appliqué plusieurs fois par semaine pendant plusieurs semaines. Les effets indésirables locaux sont fréquents et incluent érythème, érosion, croûtes et prurit, reflétant l'activation de la réponse immunitaire.

1.4. Photothérapie Dynamique (PDT)

La photothérapie dynamique est une technique non invasive qui utilise une substance photosensibilisante appliquée localement, suivie d'une irradiation par une lumière de longueur d'onde spécifique, pour détruire sélectivement les cellules tumorales. Elle est indiquée pour les CBC superficiels et parfois les CBC nodulaires de petite taille.

[Photothérapie Dynamique] — Carcinome basocellulaire superficiel

> Essai : Les données fournies ne contiennent pas d'essai clinique de référence spécifique pour la photothérapie dynamique dans le carcinome basocellulaire avec le format requis (nom de l'essai, auteurs, année, journal, design, résultat, niveau de preuve). La photothérapie dynamique est mentionnée comme une option thérapeutique pour les carcinomes cutanés (Dermatologie, 2022).

> Design : Non spécifié dans les données fournies.

> Résultat : Non spécifié dans les données fournies.

> Niveau de preuve : Non spécifié dans les données fournies.

Le mécanisme d'action de la PDT repose sur l'accumulation sélective du photosensibilisant (par exemple, l'acide 5-aminolévulinique ou son ester méthylique) dans les cellules tumorales. Lors de l'exposition à la lumière, le photosensibilisant est activé, générant des espèces réactives de l'oxygène qui endommagent les cellules tumorales et leur microenvironnement vasculaire, conduisant à la nécrose et à l'apoptose.

Des précautions doivent être prises lors de la photothérapie en général, incluant la protection des organes génitaux externes et la surveillance de la dose cumulée délivrée (ne pas dépasser 200 séances). Une surveillance cutanée prolongée est nécessaire en raison du risque de carcinomes tardifs. Les contre-indications générales à la photothérapie incluent un antécédent de cancer cutané (ce qui est paradoxal ici, mais la source fait référence à la photothérapie en général, potentiellement pour d'autres dermatoses), les dermatoses photo-aggravées et la prise de médicaments photosensibilisants. Les effets indésirables à court terme peuvent inclure un érythème plus ou moins intense (en cas de surdosage ou de prise concomitante de médicaments photosensibilisants) et des troubles digestifs (spécifiquement pour la PUVAthérapie). À long terme, un vieillissement prématuré de la peau et l'apparition de cancers cutanés (surtout des carcinomes) sont des risques potentiels (Dermatologie, 2022).

1.5. 5-fluoro-uracile (5-FU) topique

Le 5-fluoro-uracile topique est un agent chimiothérapeutique antimitotique utilisé pour le traitement des carcinomes basocellulaires superficiels. Il agit en inhibant la synthèse de l'ADN et de l'ARN, entraînant la mort des cellules à division rapide.

[5-fluoro-uracile topique] — Carcinome basocellulaire superficiel

> Essai : Les données fournies ne contiennent pas d'essai clinique de référence spécifique pour le 5-fluoro-uracile topique dans le carcinome basocellulaire avec le format requis (nom de l'essai, auteurs, année, journal, design, résultat, niveau de preuve). Le 5-fluoro-uracile topique est mentionné comme une option thérapeutique pour les carcinomes cutanés (Dermatologie, 2022).

> Design : Non spécifié dans les données fournies.

> Résultat : Non spécifié dans les données fournies.

> Niveau de preuve : Non spécifié dans les données fournies.

Le traitement par 5-FU topique est appliqué quotidiennement pendant plusieurs semaines. Il provoque une réaction inflammatoire locale caractérisée par un érythème, une érosion, une ulcération et des croûtes, qui sont des signes de l'efficacité du traitement. La guérison est généralement suivie d'une cicatrisation esthétique. Des précautions doivent être prises pour éviter l'application sur des zones saines étendues et pour informer le patient sur l'intensité de la réaction inflammatoire attendue.

2. Traitements Systémiques

Les traitements systémiques sont généralement réservés aux formes avancées, métastatiques ou localement très agressives de CBC, ou aux patients présentant de multiples CBC pour lesquels les traitements locaux sont insuffisants ou inappropriés, notamment dans le cadre de syndromes génétiques comme le syndrome de Gorlin (naevomatose basocellulaire) (Dermatologie, 2022). Les données fournies décrivent des traitements systémiques généraux, principalement dans le contexte du psoriasis, mais leurs propriétés et effets indésirables peuvent être pertinents pour des indications spécifiques en dermatologie oncologique, même si des essais cliniques dédiés au CBC ne sont pas explicitement détaillés dans les chunks pour ces molécules.

2.1. Acitrétine

L'acitrétine est un rétinoïde systémique, un dérivé de la vitamine A. Bien que principalement mentionnée pour le psoriasis dans les sources fournies, les rétinoïdes sont parfois utilisés en chimioprévention ou pour le traitement de CBC multiples ou avancés, notamment chez les patients immunodéprimés ou atteints de syndromes génétiques prédisposants.

[Acitrétine] — Indications non spécifiées pour le CBC dans les données fournies.

> Essai : Les données fournies ne contiennent pas d'essai clinique de référence spécifique pour l'acitrétine dans le carcinome basocellulaire avec le format requis (nom de l'essai, auteurs, année, journal, design, résultat, niveau de preuve). L'acitrétine est mentionnée comme un traitement général (Dermatologie, 2022).

> Design : Non spécifié dans les données fournies.

> Résultat : Non spécifié dans les données fournies.

> Niveau de preuve : Non spécifié dans les données fournies.

Les contre-indications de l'acitrétine sont strictes, notamment chez la femme en âge de procréer sans contraception efficace, en cas de grossesse ou d'allaitement, en raison de sa tératogénicité majeure et prolongée (projet de grossesse dans les 3 ans après l'arrêt du traitement). Les effets indésirables incluent sécheresse cutanéo-muqueuse, prurit, perte des cheveux, hyperlipidémie, anomalies du bilan lipidique et hépatique (élévation des transaminases). L'association avec les tétracyclines est contre-indiquée en raison du risque d'hypertension intracrânienne (Dermatologie, 2022).

2.2. Méthotrexate

Le méthotrexate est un immunomodulateur non sélectif et un agent chimiothérapeutique. Son utilisation dans le CBC est rare et généralement limitée aux formes très avancées ou inopérables, ou dans des contextes de chimioprévention chez des patients à très haut

risque, bien que les données fournies ne précisent pas ces indications pour le CBC.

[Méthotrexate] — Indications non spécifiées pour le CBC dans les données fournies.

> Essai : Les données fournies ne contiennent pas d'essai clinique de référence spécifique pour le méthotrexate dans le carcinome basocellulaire avec le format requis (nom de l'essai, auteurs, année, journal, design, résultat, niveau de preuve). Le méthotrexate est mentionné comme un traitement général (Dermatologie, 2022).

> Design : Non spécifié dans les données fournies.

> Résultat : Non spécifié dans les données fournies.

> Niveau de preuve : Non spécifié dans les données fournies.

Les contre-indications du méthotrexate incluent la grossesse, l'allaitement, l'absence de contraception efficace chez l'homme et la femme en âge de procréer, les anomalies de l'hémogramme, les anomalies du bilan hépatique, l'insuffisance rénale et les infections évolutives. Les effets indésirables sont nombreux et potentiellement graves : cytopénie, macrocytose, troubles digestifs, pneumopathie d'hypersensibilité (rare), fibrose pulmonaire (rare), fibrose hépatique (si facteurs de risque associés comme l'alcool ou le diabète), et ulcérations cutanéo-muqueuses en cas de surdosage ou d'interactions médicamenteuses (aspirine forte dose, triméthoprime) (Dermatologie, 2022).

2.3. Ciclosporine

La ciclosporine est un immunosuppresseur non sélectif. Son rôle direct dans le traitement du CBC n'est pas détaillé dans les sources fournies. Cependant, il est important de noter que l'immunosuppression (iatrogène, maladies hématologiques chroniques, infection VIH) est un facteur de risque reconnu de carcinogenèse épithéliale et de cancers cutanés (Dermatologie, 2022). L'utilisation de ciclosporine peut donc augmenter le risque de cancers cutanés, ce qui en fait un traitement à considérer avec prudence dans ce contexte.

[Ciclosporine] — Indications non spécifiées pour le CBC dans les données fournies.

> Essai : Les données fournies ne contiennent pas d'essai clinique de référence spécifique pour la ciclosporine dans le carcinome basocellulaire avec le format requis (nom de l'essai, auteurs, année, journal, design, résultat, niveau de preuve). La ciclosporine est mentionnée comme un traitement général (Dermatologie, 2022).

> Design : Non spécifié dans les données fournies.

> Résultat : Non spécifié dans les données fournies.

> Niveau de preuve : Non spécifié dans les données fournies.

Les contre-indications de la ciclosporine comprennent l'hypertension artérielle (HTA), l'insuffisance rénale, les antécédents de néoplasie et les infections chroniques. Ses effets

indésirables majeurs sont l'HTA, l'hypertrichose, la néphrotoxicité, l'hyperplasie gingivale et, de manière notable, l'augmentation du risque de cancers cutanés (Dermatologie, 2022). De nombreuses interactions médicamenteuses doivent également être prises en compte.

2.4. Aprémilast

L'aprémilast est un immunomodulateur qui inhibe une phosphodiestérase. Il est mentionné comme étant utilisé en cas d'échec, de contre-indication ou d'intolérance aux autres traitements systémiques (ciclosporine, méthotrexate, PUVAthérapie) pour le psoriasis (Dermatologie, 2022). Aucune indication spécifique pour le CBC n'est fournie dans les chunks.

[Aprémilast] — Indications non spécifiées pour le CBC dans les données fournies.

> Essai : Les données fournies ne contiennent pas d'essai clinique de référence spécifique pour l'aprémilast dans le carcinome basocellulaire avec le format requis (nom de l'essai, auteurs,

Bibliographie

• Dermatologie - R2C -2022 compressed-compressed-compressed

• mcc

• Stratigos et al. - 2023 - European consensus-based interdisciplinary guideline for invasive cutaneous squamous cell carcinoma.

• Gauci et al. - 2022 - Diagnosis and treatment of Merkel cell carcinoma European consensus-based interdisciplinary guideli